

République Tunisienne
Université de Sousse
Faculté de Médecine Ibn Al Jazzar de Sousse

**Examen blanc de l'examen d'entrée au troisième cycle
des études médicales 2019
(Epreuve 2)**

L'épreuve comprend 22 pages et 125 questions, réparties comme suit :

- 70 QCM (questions de 1 à 70)**
- 16 cas cliniques QCM (questions de 71 à 125)**

Durée de l'épreuve : 2h 30min

Bon travail

QCM

1. Devant une polyadénopathie avec un syndrome mononucléosique vous évoquez les étiologies suivantes :

- A- primo-infection à VIH
- B- mononucléose infectieuse
- C- lymphome malin non hodgkinien
- D- toxoplasmose
- E- maladie des griffes de chat

2. Devant une mono adénopathie cervicale, vous évoquez le diagnostic de tuberculose ganglionnaire devant la présence de :

- A- autres localisations extra-ganglionnaires
- B- signes d'imprégnation tuberculeuse
- C- granulomes à l'histologie
- D- leucopénie
- E- fistulisation

3. La présence d'un ganglion de Troisier oriente vers la recherche d'une néoplasie de :

- A-œsophage
- B- poumon droit
- C- angle colique droit
- D- sommet du poumon gauche
- E- endomètre

4. Ces diagnostics doivent être évoqués devant des adénopathies cervicales :

- A- leucémie aigue
- B- leucémie myéloïde chronique
- C- hémoglobinurie paroxystique nocturne
- D- leucémie lymphoïde chronique
- E- lymphome hodgkinien

Un patient porteur d'une leucémie lymphoïde chronique présente la numération suivante : GB : $100.000/\text{mm}^3$ (lymphocytes : $90.000/\text{mm}^3$), Hb 6 g/dl et plaquettes $50.000/\text{mm}^3$

5. Quel est le stade de la maladie ?

- A- Stade A
- B- Stade I
- C- Stade B
- D- Stade III
- E- Stade C

6. Les causes physiologiques du déséquilibre du bilan du fer sont les suivantes, sauf une. Laquelle ?

- A- Les pertes menstruelles
- B- La croissance
- C- La grossesse
- D- L'allaitement
- E- La sénescence

7. La vitesse de conduction électrique est la plus rapide au niveau :

- A- du nœud sinusal
- B- des oreillettes
- C- du faisceau de Hiss
- D- des fibres de Purkinje
- E- du nœud auriculo-ventriculaire

8. Le potentiel de repos d'une cellule musculaire cardiaque banale :

- A- est de l'ordre de -90 mV
- B- dépend de la perméabilité membranaire aux ions Na^+ , K^+ et Ca^{++}
- C- est instable
- D- est maintenue grâce à la pompe Na^+/K^+ ATP ase
- E- est égale à celui du tissu nodal

9. Les cellules du tissu nodal :

- A- sont excitables
- B- sont douées d'un automatisme
- C- sont innervées uniquement par le système parasympathique
- D- sont conducteurs
- E- ont un potentiel de repos stable

10. Les critères de gravité d'une bronchiolite sont :

- A- fréquence respiratoire > 60 /minute
- B- saturation artérielle en oxygène (SpO_2) $> 94\%$
- C- troubles digestifs compromettant l'alimentation
- D- déshydratation avec perte de poids $> 5\%$
- E- présence de signes de lutte respiratoire

11. Une bronchiolite du nourrisson peut se compliquer de :

- A. pneumothorax,
- B. pneumo médiastin
- C. une sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique
- D. apnée
- E. insuffisance cardiaque

12. Les signes radiologiques qu'on peut voir en cas de bronchiolite ?

- A. distension
- B. épaississement péri bronchique
- C. atélectasie
- D. foyer alvéolaire
- E. Epanchement pleural

13. Peut ou peuvent entrainer un coma calme hypotonique, une ou plusieurs réponse(s) est ou sont exacte(s):

- A- benzodiazépine
- B- monoxyde de carbone
- C- barbiturique
- D- cocaïne
- E- hypoglycémie

14. Lors de l'examen d'un patient comateux :

- A- la persistance de signes traduisant un contrôle cortical, discordants avec la profondeur apparente du coma est en faveur d'une aréactivité psychogène.
- B- lors du locked-in syndrome les mouvements de latéralité des yeux sont conservés.
- C- la présence des signes de localisation impose la réalisation d'imagerie cérébrale.
- D- le mutisme akinétique s'exprime par une altération de la vigilance.
- E- l'évaluation du Glasgow coma score est inutile.

15. Dans les comas dépassés ou mort cérébrale :

- A- il n'y a plus de respiration spontanée
- B- il y a un arrêt circulatoire à l'angiographie carotidienne
- C- il n'y a plus de réflexe cornéen
- D- on observe une hypertonie de décérébration
- E- l'électroencéphalogramme est toujours plat.

16. Chez le nourrisson le plus grand compartiment liquidien de son organisme est le secteur :

- A- interstitiel
- B- plasmatique
- C- intracellulaire
- D- trancellulaire
- E- vasculaire

17. Une déshydratation extracellulaire isolée est caractérisée par :

- A- Une diminution du volume du liquide extracellulaire
- B- Une isotonie du liquide extracellulaire
- C- Une natrémie normale
- D- Une hypotonie intracellulaire
- E- Un volume intracellulaire augmenté

18. Le nourrisson est particulièrement plus vulnérable à la déshydratation que l'adulte à cause :

- A- de l'immaturité de ses reins
- B- de l'importance de ses pertes insensibles d'eau
- C- de l'immaturité de sa thermorégulation
- D- des troubles glycémiques plus fréquents
- E- du développement de sa masse musculaire

19. La perception de la douleur :

- A- est la même chez tous les individus pour une intensité de stimulation donnée
- B- a une composante cognitive qui dépend des antécédents du sujet
- C- peut produire une modification de l'affection et de l'émotion
- D- est un phénomène objectif
- E- est conservée après une lésion des voies de transmission de la douleur

20. Parmi les antalgiques suivants, lesquels appartiennent au palier II :

- A- la morphine
- B- l'aspirine
- C- le tramadol

- D- le kétoprofène
- E- l'association codéine-paracétamol

21. Donnez les effets indésirables des AINS :

- A- dépression respiratoire
- B- gastralgie, ulcération gastrique
- C- épistaxis
- D- néphrotoxicité
- E- oedème de Quincke

22. Les actions physiologiques de la morphine sont :

- A- diminution du péristaltisme intestinal et augmentation des sécrétions intestinales
- B- action vasodilatatrice
- C- action broncho constrictrice
- D- hypotension
- E- effet toxicomanogène

23. L'hépatotoxicité du paracétamol :

- A- est due à un métabolite du paracétamol
- B- est potentiellement mortelle
- C- il n'existe pas d'antidote
- D- nécessite une prise en charge spécialisée
- E- ne se voit qu'à partir de 300mg/kg.

24. Les résistances vasculaires sont régulées par le (les) facteur(s) suivant(s) :

- A- neurofibres vasoconstrictrices sympathiques
- B- neurofibres parasympathiques
- C- catécholamines circulantes
- D- système rénine angiotensine
- E- l'âge

25. Concernant la tamponnade cardiaque, quelle est la réponse vraie ?

- A- elle ne se révèle jamais par une anurie
- B- elle s'accompagne toujours d'une douleur rétro sternale
- C- elle doit être évoquée devant un état de choc associé à des signes d'insuffisance cardiaque droite
- D- elle ne complique pas la dissection aortique
- E- la dyspnée est le signe fonctionnel majeur

26. Le profil hémodynamique suivant : débit cardiaque bas, élévation des résistances vasculaires systémiques, élévation de la pression auriculaire droite et de la pression artérielle d'occlusion pulmonaire, obtenu chez un patient en choc est en faveur d'un choc d'origine :

- A- cardiogénique
- B- anaphylactique
- C- hémorragique
- D- hypovolémique
- E- hypoxique

27. L'hypoxémie peut entraîner la (les) manifestation(s) suivante(s) :

- A- tachycardie
- B- vasodilatation coronaire
- C- vasoconstriction cérébrale

- D- vasoconstriction splanchnique
- E- vasodilatation rénale

28. Quelles sont les propositions vraies concernant les mécanismes de compensation de l'organisme face à une hypovolémie :

- A- Vasodilatation artérielle systémique
- B- Vasodilatation veineuse systémique
- C- Vasoconstriction artérielle systémique
- D- Vasoconstriction veineuse systémique
- E- Augmentation du débit cardiaque.

29. Parmi les propositions suivantes, lesquelles correspondent à des produits de remplissage vasculaire ?

- A- sérum physiologique
- B- ringer lactate
- C- hydroxy éthyl amidon
- D- albumine
- E- plasma frais décongelés.

30. Parmi les causes gynéco obstétricales les plus fréquentes du choc hémorragique on retrouve :

- A- la grossesse extra utérine rompue
- B- les kystes ovariens
- C- le placenta prævia
- D- l'hématome rétro placentaire
- E- le cancer de l'ovaire

31. La prévention d'ostéite en cas de fracture ouverte de jambe repose sur plusieurs éléments. Lesquels ?

- A- parage de la plaie
- B- antibiothérapie
- C- prophylaxie antitétanique
- D- prophylaxie de phlébite
- E- Immobilisation du foyer de fracture

32. Le choix d'une antibiothérapie probabiliste repose sur :

- A. Le degré de gravité du sepsis
- B. L'écologie bactérienne de l'origine de l'infection
- C. Le terrain du malade
- D. Les résultats des prélèvements microbiologiques
- E. La portée d'entrée de l'infection

33. Les éléments suivants orientent vers un germe multi-résistant :

- A. Antécédents d'hospitalisation
- B. Patient dialysé
- C. Patient vivant dans une maison de retraite
- D. Jeune âge
- E. Coloscopie faite il y a 48 h sous AG

34. Les conséquences du choc septique sur l'hémostase sont:

- A. Activation du système pro coagulation
- B. Dépassement du système fibrinolytique
- C. Inhibition des systèmes anticoagulants naturels

- D. Une augmentation de la concentration plasmatique de l'anti thrombine ...
- E. Un déficit de la protéine C

35. Une hématurie microscopique détectée à la bandelette, peut orienter vers :

- A- une lithiase des voies urinaires
- B- une infection urinaire
- C- une néphropathie glomérulaire
- D- une tumeur de la vessie
- E- une prise de rifampicine

36. Les agents carcinogènes identifiés dans la genèse des tumeurs de la voie excrétrice sont :

- A- l'aniline
- B- la phénacétine
- C- l'irritation chronique
- D- le tabac
- E- l'alcool

37. Une hématurie associée à une douleur lombaire peut évoquer toutes les étiologies sauf une, laquelle ?

- A- lithiase rénale
- B- nécrose papillaire
- C- infarctus rénal
- D- thrombose de la veine rénale
- E- glomérulonéphrite aiguë post-streptococcique

38. Un diabétique doit éviter de pratiquer:

- A- le judo
- B- le semi marathon
- C- la natation
- D- la plongée sous marine
- E- le sport de vitesse

39- Dans l'acidocétose diabétique, il existe:

- A- un trou anionique
- B- un déficit de potassium
- C- une élévation des bicarbonates
- D- une déshydratation intra cellulaire
- E- un déficit en phosphates

40. Une prévention est possible dans le diabète:

- A- de type 1
- B- de type 2
- C- monogénique
- D- gestationnel
- E- iatrogène

41. Au cours de l'hypothyroïdie primaire, l'infiltration myxœdémateuse entraîne :

- A- une asthénie
- B- une frilosité
- C- une péricardite

- D- des ronflements nocturnes
- E- une prise de poids

42. Les signes muscariniques d'une intoxication aigue aux organophosphorés sont :

- A- myosis
- B- fasciculations musculaires
- C- somnolence
- D- incontinence urinaire
- E- hypersécrétion salivaire

43. Quel est le traitement spécifique de l'intoxication aigue par les organophosphorés ?

- A- administration d'atropine
- B- assistance ventilatoire
- C- charbon activé
- D- correction troubles hydro-électrolytiques
- E- administration des réactivateurs de l'acétylcholinestérase

44. Une oxygénothérapie hyperbare est indiquée en cas d'une intoxication au CO :

- A- chez la femme enceinte
- B- avec trouble de la conduction
- C- chez le sujet âgé
- D- avec agitation
- E- avec un taux d'Hb CO > 15%

45. Quelles sont les caractéristiques d'une intoxication aux neuroleptiques ?

- A- syndrome anti cholinergique
- B- hypertension
- C- coma hypotonique
- D- arythmie
- E- bradycardie

46. Devant une créatininémie élevée, quels arguments retenez-vous en faveur d'une insuffisance rénale aiguë?

- A- reins de taille diminuée
- B- oligurie
- C- absence de péricardite
- D- absence d'anémie et d'hypocalcémie
- E- fonction rénale antérieure normale

47. Quelles sont les trois principales complications de l'IRA à rechercher en urgence ?

- A- hypercalcémie
- B- hyperkaliémie
- C- œdème aigu pulmonaire
- D- alcalose métabolique
- E- acidose métabolique

48. Dans une insuffisance rénale aigue par nécrose tubulaire aigue :

- A- la récupération de la fonction rénale antérieure est la règle
- B- la phase d'anurie est constante
- C- le rapport urinaire Na/k est supérieur à 1
- D- les diurétiques sont contre indiqués

E- le sédiment urinaire est inactif

49. Au cours d'une IRA, les indications de l'épuration extra-rénale sont :

- A- oedèmes des membres inférieurs
- B- hyperkaliémie menaçante
- C- urée > 30mmol/l
- D- anémie
- E- protéinurie et/ou hématurie abondante

50. Quel est le seul examen biologique devant obligatoirement être réalisé aux urgences lors de la prise en charge d'une crise de colique néphrétique aiguë simple ?

- A- NFS
- B- créatinine
- C- lactates
- D- CRP
- E- ionogramme sanguin

51. Quels bilans métaboliques de première intention d'un calcul ?

- A- la diminution de la pression hydrostatique dans le pôle artériolaire des capillaires
- B- l'augmentation de la pression hydrostatique dans le capillaire veineux
- C- une obstruction des capillaires lymphatiques
- D- une baisse de la pression oncotique interstitielle
- E- un trouble de la perméabilité capillaire

52. Le calcul urinaire :

- A- peut être invisible à l'AUSP
- B- se traduit à l'échographie par une formation hyper échogène avec un renforcement postérieur
- C- son aspect échographie est variable selon sa composition cristalline
- D- peut se traduire à l'UIV par une image lacunaire
- E- est presque toujours visible au scanner

53. La transmission sexuelle des papillomavirus humains(HPV)

- A. est possible par voie orale
- B. est possible par voie anale
- C. n'est possible que si le rapport sexuel est pénétrant
- D. non oncogènes protège contre la transmission des types oncogènes
- E. est prévenue par un vaccin qui couvre tous les génotypes

54. Le diagnostic virologique direct au laboratoire pour un herpès génital est possible sur ce(s)prélèvement(s) :

- A. prélèvement du contenu d'une vésicule par seringue
- B. écouvillonnage appuyé du fond d'une vésicule
- C. écouvillonnage appuyé au niveau des ulcérations
- D. prélèvement vaginal
- E. prélèvement sanguin

55. Devant un écoulement urétral :

- A- les deux germes à suspecter en premier sont *N. gonorrhoeae* et *Trichomonas vaginalis*
- B- un examen à visée microbiologique doit être fait avant tout traitement
- C- on doit demander immédiatement les sérologies de VIH, VHB et de la syphilis
- D- on doit systématiquement essayer de prendre en charge le ou les partenaires sexuels

E- L'antibiothérapie probabiliste repose sur l'association ciprofloxacine et amoxicilline

56. Une ponction lombaire doit être précédée d'un scanner cérébral pour un patient suspect de méningite en cas de :

- A- score de Glasgow ≤ 10
- B- déficit moteur d'un membre
- C- céphalées intenses
- D- fièvre $> 40^{\circ}\text{C}$
- E- crise convulsive localisée

57. La récurrence d'une méningite purulente est favorisée par :

- A- une infection au VIH
- B- une brèche ostéoméningée
- C- un déficit en complément
- D- un traumatisme crânien
- E- une néoplasie évolutive

58. Dans la méningite tuberculeuse :

- A- le syndrome méningé est franc
- B- les manifestations psychiatriques sont fréquentes
- C- il n'existe pas de signes basilaires
- D- on peut observer une paralysie oculomotrice
- E- le pronostic est souvent réservé

59- La prise en charge en pré hospitalier:

- A. La protection du rachis cérébral est une priorité
- B. Un traumatisé crânien grave est considéré comme blessé médullaire jusqu'à preuve du contraire
- C. On peut utiliser comme soluté vecteur du SG5% pour éviter les hypoglycémies
- D. L'utilisation du mannitol pour traiter un engagement cérébral suspecté est proscrite en pré hospitalier
- E. L'objectif est de maintenir une TAS $> 100\text{mmHg}$

60- L'œdème cérébral :

- A. peut générer une hypertension intracrânienne
- B. Peut être de type cytotoxique par altération de la barrière hémato encéphalique
- C. est souvent focalisé en péri lésionnel
- D. Le brain swelling est une forme d'œdème généralisé du cerveau
- E. Au scanner, l'œdème cérébral apparaît comme une hyperdensité en halo entourant la lésion

61- Le score de Glasgow (GCS) :

- A. utilise 5 critères d'évaluation.
- B. La méthode de stimulation nociceptive validée est le pincement des mamelons.
- C. Un traumatisme facial peut entraver le calcul du GCS.
- D. Lors du calcul du GCS, pour chaque critère et en cas d'asymétrie, on considère la moins bonne réponse.
- E. Est le principal outil d'évaluation de la gravité d'un traumatisme crânien.

62. La réabsorption rénale des bicarbonates augmente dans les situations suivantes :

- A- hypovolémie
- B- hyperkaliémie
- C- hypercapnie
- D- déplétion chlorée

E- inhibition de l'anhydrase carbonique

63- Les limites du pH urinaire chez l'Homme normal est de :

- A. 1-3
- B. 2-4
- C. 4-8
- D. 5-7
- E. 6-9

64. L'œdème localisé d'un membre supérieur peut être du à :

- A- une malformation vasculaire
- B- une algodystrophie
- C- un kyste de Baker rompu
- D- une arthrite
- E- une insuffisance hépatocellulaire

65. Dans la thrombose veineuse profonde d'un membre inférieur:

- A- l'œdème est inconstant.
- B- le diagnostic est à évoquer devant un cordon veineux douloureux.
- C- la profession avec position debout prolongée est un facteur favorisant.
- D- le diagnostic est confirmé par échographie doppler veineux des membres inférieurs.
- E- une dyspnée récente en est un signe de gravité.

66- Quels sont les vaccins obligatoires chez le grand enfant ?

- A. Tétanos
- B. Poliomyélite injectable
- C. BCG
- D. Hépatite B
- E. ROR

67- Le vaccin BCG :

- A. Est un vaccin vivant atténué
- B. Est administré à l'âge de 1an
- C. Est administré par voie orale
- D. Peut se compliquer d'une adénite
- E. Peut être associé à un autre vaccin

68- Le schéma thérapeutique antirabique chez une personne mordue par un animal dépend :

- A- De l'endémicité de la rage dans la localité où habite l'agressé.
- B- De la profondeur et du nombre des lésions.
- C- De l'observation de l'animal par un vétérinaire.
- D- Du siège, de la profondeur des lésions et de l'état de l'animal.
- E- Aucune réponse n'est correcte.

69- La constatation d'un myosis bilatéral chez un malade dans le coma doit faire évoquer :

- A- Une intoxication par les barbituriques
- B- Une intoxication aux antidépresseurs tricycliques
- C- Une intoxication atropinique
- D- Une intoxication par les opiacés
- E- Une dissection carotidienne

70- L'état végétatif :

- A- Il est synonyme de mort cérébrale
- B- Les reflexes cornéens et photomoteurs sont généralement conservés
- C- Il existe une réaction appropriée aux stimulations douloureuses
- D- Les fonctions respiratoires et cardiovasculaires sont habituellement conservées
- E- La récupération d'une conscience normale est fréquente

Cas cliniques QCM

Cas clinique 1 :

Vous avez identifié chez une malade de 65 ans un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur. Par ailleurs, la patiente rapporte des épigastralgies intermittentes évoluant depuis plusieurs semaines. L'examen général retrouve une pâleur cutanéomuqueuse.

Le bilan biologique trouve : Hb = 10,1 g/dL, VGM = 118 fL, plaquettes = 234 G/L, leucocytes = 4,7 G/L dont 2,4 G/L de PNN (le reste de la formule leucocytaire est normal), réticulocytes = 36 G/L ; – CRP = 5 mg/L ; l'ionogramme plasmatique et la fonction rénale sont normaux.

71. Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) pouvant être évoqué(s) devant cette anémie macrocytaire ?

- A. Consommation chronique d'alcool
- B. Hypothyroïdie
- C. Syndrome myélodysplasique
- D. Myélome multiple
- E. Beta thalassémie mineure

72. Quel(s) mécanisme(s) physiopathologique(s) peu(ven)t expliquer la macrocytose observée chez cette patiente ?

- A. Augmentation du taux de réticulocytes dans le cadre d'une anémie aigue régénérative
- B. Défaut de stimulation de l'érythropoïèse par une hypothyroïdie
- C. Anomalie primitive de la globine comme dans les thalassémies
- D. Anomalie intrinsèque de la cellule souche hématopoïétique comme dans les syndromes myélodysplasiques
- E. Un défaut de synthèse d'ADN cause par une carence en vitamines B9 et/ou B12

73. Comment allez-vous compléter en première intention le bilan biologique ci-dessus afin d'explorer cette anémie ?

- A. Myélogramme
- B. Biopsie ostéomédullaire
- C. Bilan hépatique (ASAT, ALAT, GGT, PAL, bilirubinémie)
- D. TSH
- E. Frottis sanguin

Cas clinique 2 :

Une patiente âgée de 30 ans, sans antécédents pathologiques, enceinte à 24 semaines d'aménorrhée, consulte pour brûlures mictionnelles avec fièvre chiffrée à 38,5° et douleur lombaire gauche évoluant depuis 48 heures. Examen physique : T°39°, FC 100/min, TA 12/7 ; douleur à la palpation de la fosse lombaire gauche. Vous suspectez une pyélonéphrite aigue.

74- Quels examens complémentaires demandez-vous ?

- A- ECBU
- B- échographie de l'appareil urinaire
- C- échographie obstétricale
- D- hémocultures
- E- uroscan

75- Quelle antibiothérapie prescrivez-vous ?

- A- amoxicilline - acide clavulanique
- B- ciprofloxacine
- C- céfixime
- D- céfotaxime
- E- gentamicine

L'évolution clinique était favorable. L'ECBU était positif à *Escherichia coli* de phénotype sauvage.

76- Quelle antibiothérapie de relais de 1^{ère} intention prescrivez-vous ?

- A- amoxicilline
- B- amoxicilline - acide clavulanique
- C- céfixime
- D- ceftriaxone
- E- cotrimoxazole

77- Quelle est la durée totale de l'antibiothérapie :

- A- 5 jours
- B- 7 jours
- C- 10 jours
- D- 21 jours
- E- 28jours

78- Après la guérison de la pyélonéphrite aigue chez cette patiente, un ECBU de contrôle :

- A- n'est pas nécessaire en l'absence de signes d'infection urinaire
- B- doit être réalisé pour dépister une bactériurie asymptomatique
- C- doit être réalisé 10 jours après l'arrêt du traitement
- D- doit être réalisé tous les 15 jours jusqu'à l'accouchement
- E- doit être réalisé tous les mois jusqu'à l'accouchement

Cas clinique 3 :

Vous êtes appelé à prendre en charge un homme de 40 ans dans un appartement incendié par les flammes. A l'évaluation initiale : GCS 14/15, TA: 100/50mmHg, FC: 120 bpm, SpO2 (AA): 92 %, SCB 25%.

79. Quelle doit être la première mesure à réaliser à votre arrivée ?

- A. Conditionnement du patient
- B. Extraction du patient
- C. Examen clinique du patient
- D. Refroidissement des lésions de brulure
- E. Injection d'hydroxocobalamine

Le patient s'aggrave rapidement sur les plans hémodynamique (PA 75/53 mm Hg, FC 115 bpm) et respiratoire (SpO2 83 % à l'air ambiant).

80. Choisissez parmi les propositions suivantes les mesures thérapeutiques qui doivent être réalisées immédiatement?

- A. Remplissage vasculaire par sérum glucosé
- B. Oxygénothérapie par masque à haute concentration
- C. Antibiothérapie à large spectre
- D. Remplissage vasculaire par cristalloïde
- E. Pose de 2 voies veineuses périphériques

81. Malgré vos mesures, le patient s'aggrave toujours sur le plan hémodynamique. Quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous faire?

- A. Intoxication au cyanure
- B. Choc septique
- C. Choc hémorragique
- D. Choc hypovolémique
- E. Intoxication au monoxyde de carbone

82. Quelle(s) mesure(s) thérapeutique(s) supplémentaire(s) préconisez-vous?

- A. Injection d'hydroxocobalamine
- B. Remplissage par 20mL/kg de cristalloïde en 1h
- C. Remplissage par 200mL/kg de cristalloïde en 1h
- D. Transfert en caisson hyperbare
- E. Remplissage par 20mL/kg de sérum glucosé en 2h

Cas clinique 4 :

Un patient âgé de 22 ans présente le profil métabolique suivant: cholestérol total: 1,8 g/l; triglycérides: 15 g/l; HDL-cholestérol: 0,6 g/l; glycémie: 4,8 mmol/l Son sérum à jeun est lactescent.

A l'épreuve de décantation, on trouve un collet avec un surnageant crémeux

Sur le plan clinique: IMC: 23; TA: 120/88 mm Hg; absence de xanthome; foie et rate normaux.

Pas de médicament ni de prise d'alcool.

83. Quelle lipoprotéine présente ce patient en excès?

- A- LDL
- B- VLDL
- C- chylomicrons
- D- HDL
- E- IDL

84. Ce patient risque:

- A- un diabète de type 1
- B- un diabète de type 2
- C- une pancréatite aiguë
- D- un IDM
- E- un AVC

85. Ce patient peut être traité par:

- A- régime pauvre en graisses

- B- régime pauvre en glucides
- C- biguanides
- D- fibrates
- E- statines

Cas clinique 5 :

Une femme de 35 ans a perdu 10 kg en 6 mois, sans avoir modifié son alimentation. Elle est nerveuse et agitée, ses mains tremblent et sont chaudes. Elle présente une exophtalmie bilatérale importante avec rougeur conjonctivale et rétraction palpébrale et une asynergie oculo-palpébrale, sans autres troubles visuels. Sa thyroïde est hypertrophiée d'une manière globale, homogène et indolore. Sa TA est à 135/75 mmHg, son pouls est à 110 battements/min. Une hyperthyroïdie est évoquée.

86. Cette patiente est susceptible de présenter cliniquement :

- A. une constipation
- B. une arythmie complète par fibrillation auriculaire
- C. un oedème pré tibial
- D. un épisode délirant
- E. une hypothermie

87. Cette patiente est susceptible de présenter les anomalies para-cliniques suivantes:

- A. Une élévation des transaminases
- B. Une hypocholestérolémie
- C. Des anticorps anti-récepteur de la TSH positifs
- D. Une TSH élevée
- E. Une hypercalcémie.

88. Concernant l'exploration de cette patiente :

- A. la scintigraphie thyroïdienne est nécessaire
- B. la scintigraphie thyroïdienne est blanche
- C. l'échographie est l'examen de première intention
- D. la thyroïde est hypo échogène à l'échographie
- E. l'écho doppler montre une hyper vascularisation

89. En absence de traitement, cette patiente risque :

- A. Une diplopie
- B. Une subluxation des globes oculaires
- C. Une neuropathie optique
- D. Une kératite d'exposition
- E. Un glaucome

Cas clinique 6 :

Une femme de 30 ans consulte pour aménorrhée secondaire depuis 4 mois. Elle n'a pas d'antécédent pathologique particulier. Après la naissance de son second enfant, actuellement âgé de 8 mois, le retour de couches s'est fait normalement. Par la suite elle a eu deux cycles spontanés et depuis, elle est en aménorrhée, sans bouffées de chaleur. Elle a allaité son enfant. Sa contraception est assurée par un dispositif intra-utérin.

L'interrogatoire découvre qu'elle a présenté, juste après son accouchement, une perte de poids de 4 kg, accompagnée d'asthénie et de palpitations. Elle a ensuite rapidement retrouvé son poids normal et a même constaté une tendance à la prise de poids sans avoir modifié son alimentation. Elle se sent fatiguée. Elle se plaint de crampes musculaires et de ballonnement abdominal.

L'examen physique trouve une thyroïde ferme et hétérogène sans nodule à la palpation. Le bilan hormonal objective une TSH à 6 mUI/ml (normale : 0,2-4,5) et une T4 libre à 10 pg/ml (normale : 7-19). Les anticorps anti thyroperoxydase et anti thyroglobuline sont présents à des titres élevés.

90. Ce tableau clinique peut correspondre à :

- A- Une thyroïdite de De Quervain
- B- Une maladie de Basedow
- C- Une thyroïdite du post-partum
- D- Un syndrome de Sheehan
- E- Une thyroïdite de Riedel

91- Son tableau clinique actuel est expliqué par :

- A- une hyperplasie vésiculaire thyroïdienne
- B- une fibrose thyroïdienne
- C- une infiltration lympho plasmocytaire thyroïdienne
- D- une atteinte virale thyroïdienne
- E- une lésion hypophysaire

92. Parmi les causes suivantes d'hypothyroïdie périphérique, laquelle (lesquelles)s peut (peuvent) réaliser une hypothyroïdie transitoire?

- A- Hypothyroïdie secondaire à la prise d'amiodarone (Cordarone®)
- B- Thyroïdite subaiguë de De Quervain
- C- Thyroïdectomie totale
- D- Thyroïdite du post - partum
- E- Myxoedème primaire de la femme ménopausée

Cas clinique 7 :

Une jeune femme de 25 ans présente un diabète de type 1 depuis l'âge de 10 ans, habituellement bien équilibré par une insulinothérapie optimisée par 4 injections par jour. Depuis quelques mois, elle se plaint d'une asthénie, d'un amaigrissement inexpliqué de 5 kg. Il s'y associe des hypoglycémies à répétition, malgré la réduction des doses d'insuline. Après un entraînement sportif, elle présente des nausées et des douleurs abdominales. Elle ne parvient pas à s'alimenter et doit finalement être hospitalisée en urgence. À l'arrivée à l'hôpital, elle présente un coma agité. La glycémie capillaire est à 0,35 g/L. L'examen clinique retrouve une déshydratation et une mélanodermie.

93. Vous suspectez une décompensation aigue d'une insuffisance surrénalienne périphérique devant :

- A. Hypoglycémies malgré la réduction des doses d'insuline
- B. Amaigrissement
- C. Douleurs abdominales
- D. Pic hypertensif
- E. L'ancienneté du diabète depuis 10ans

94. Quelle serait l'étiologie la plus probable de cette insuffisance surrénalienne ?

- A. Tuberculose surrénalienne
- B. Auto immune
- C. Insuffisance corticotrope
- D. Métastases surrénaliennes bilatérales

E. Hypophysite

95. Quels bilans demandez-vous en urgence ?

- A. Dosage de cortisol
- B. Dosage d'ACTH
- C. Test de Synacthène®
- D. Test d'hypoglycémie insulinique
- E. Dosage d'aldostérone

L'ionogramme sanguin retrouve une natrémie à 123 mmol/L, avec kaliémie à 5,8 mmol/L, glycémie à 0,38 g/L.

96. Quel serait votre conduite en urgence ?

- A. Perfusion de sérum glucosé
- B. Supplémentation en NaCl
- C. Supplémentation en KCl
- D. Hémisuccinate d'hydrocortisone en IV
- E. Arrêt définitif de l'insuline

97. Après amélioration clinique, le traitement comportera :

- A. Hydrocortisone
- B. Prednisone
- C. Dexaméthasone
- D. Fluorocortisone
- E. Régime sans sels

Cas clinique 8 :

Une jeune femme vient vous consulter avec une sérologie syphilis positive sachant qu'elle eu une ulcération génitale qui serait un chancre syphilitique non traité il y a 9 mois.

L'examen clinique est sans particularités.

98. Vous évoquez :

- A. Une syphilis primaire
- B. Une syphilis secondaire
- C. Une syphilis précoce latente
- D. Une syphilis tardive latente
- E. Une syphilis tertiaire

99. Parmi les propositions suivantes, quel serait le traitement le plus approprié ?

- A- Benzathine pénicilline G : 1 injection de 2,4 Millions d'unités en IM.
- B- Benzathine pénicilline G : 1 injection IM de 2,4 MU / semaine x 3 semaines.
- C- Pénicilline G 24 millions pendant 14 jours
- D- Doxycycline 100 mg x 2/jour per os pendant 14 jours.
- E- Ceftriaxone 2 g/j pendant 14 jours

100. Quelle serait votre stratégie de prise en charge chez son partenaire sexuel :

- A- Antibiothérapie de la syphilis sans faire de sérologie
- B- Demander TPHA et VDRL
- C- Demander la sérologie VIH et la sérologie VHB
- D- Demander la sérologie du VHC
- E- Vaccination contre la VHB sans faire de sérologie

Cas clinique 9 :

Un homme de 45 ans aux antécédents d'éthylisme et d'angine 8 jours avant est hospitalisé pour exploration d'un syndrome œdémateux. L'examen physique trouve une TA à 120/80 mm Hg, une fréquence respiratoire à 17 cycles/mn, un silence auscultatoire à la base pulmonaire droite, une ascite et un œdème bilatéral des membres inférieurs blancs mous gardant le godet et indolores.

101-Quel examen commencez-vous par demander pour déterminer l'origine des œdèmes ?

- A- Une ponction d'ascite
- B- Une échographie cardiaque
- C- Une ponction pleurale
- D- Une échographie abdominale
- E- Une bandelette urinaire

Le lendemain de son admission, le patient se plaint d'une dyspnée aiguë avec crachats hémoptoïques.

L'examen trouve une température à 38°C, une fréquence cardiaque à 110B/mn, une fréquence respiratoire à 22 cycles/mn, un silence auscultatoire à la base droite, une palpation douloureuse de l'hypochondre droit avec reflux hépato jugulaire et une douleur avec tension du mollet gauche.

102. Choisissez parmi les propositions suivantes le diagnostic le plus probable ?

- A- Une cirrhose éthylique décompensée par une infection d'ascite
- B- Une hypothyroïdie décompensée par une infection pulmonaire
- C- Une insuffisance cardiaque droite décompensée par une infection pulmonaire
- D- Un syndrome néphrotique pur compliqué d'une phlébite et une embolie pulmonaire
- E- Une glomérulonéphrite aiguë post infectieuse

103. Quel (s) examen (s) demandez-vous en urgence pour vous aider au diagnostic ?

- A- Un gaz du sang artériel
- B- Une échographie cardiaque
- C- Un doppler veineux des membres inférieurs
- D- Une biopsie hépatique
- E- Une biopsie rénale

Cas Clinique 10 :

Une femme de 38 ans, femme au foyer, présente des arthralgies des mains et des pieds depuis 12 semaines. En raison de la douleur, elle est réveillée presque toutes les nuits à 4h00 du matin. Elle se plaint également d'un dérouillage matinal de 60 mn.

L'examen clinique montre un gonflement du poignet droit, de la 2^{ème} métacarpophalangienne (MCP) des 2 mains ainsi qu'une douleur bilatérale à la pression transverse des MCP et des métatarso phalangiennes (MTP).

104. Quels diagnostics peuvent être évoqués à cette étape ?

- A- Polyarthrite rhumatoïde débutante
- B- Arthrose des mains
- C- goutte
- D- Lupus érythémateux systémique
- E-Spondylarthrite ankylosante

105- Parmi les examens biologiques suivants, lesquels devraient être réalisés pour étayer le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde :

- A- Les anticorps anti peptides citrullinés
- B- Les anticorps anti nucléaires
- C- Le facteur rhumatoïde
- D- Les anticorps anti cytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA)
- E- Dosage pondéral des immunoglobulines

106. quelles sont les radiographies à demander de première intention?

- A- radiographies des mains de face
- B- radiographies des poignets de face
- C- radiographies des genoux de face
- D- radiographie du rachis lombaire (face et profil)
- E- radiographie des avant pieds

Cas Clinique 11 :

Un patient de 10 ans, consulte pour fièvre, sueurs nocturnes évoluant depuis 3 mois. L'examen révèle une splénomégalie de 10cm douloureuse avec ascite de faible abondance, une hépatomégalie (FH : 15 cm), absence d'adénopathies périphériques.

Le bilan biologique montre : Hb 9g/dl, VGM 82 μm^3 , TCMH 27 pg, Réticulocytes : 56000/mm³, GB = 3200 /mm³, PNN = 1000/mm³, Lymphocytes = 1500/mm³, Plaquettes = 90 000/mm³ ; CRP = 150 mg/L.

107. A ce stade quel(s) diagnostic(s) évoquez-vous chez ce patient :

- A- Une tuberculose des organes hématopoïétiques.
- B- Une Brucellose.
- C- Une fièvre typhoïde.
- D- Une leucémie myéloïde chronique.
- E- Une mononucléose infectieuse.

108. La reprise de l'interrogatoire a retrouvé une notion de cas similaire dans la famille et de contag. Vous retenez comme diagnostic :

- A- Une tuberculose des organes hématopoïétiques.
- B- Une Brucellose.
- C- Une fièvre typhoïde.
- D- Une leucémie myéloïde chronique.
- E- Une mononucléose infectieuse.

109. Les examens complémentaires à demander pour confirmer votre diagnostic sont :

- A-IDR à la tuberculine
- B-Myélogramme avec myéloculture
- C-Ponction biopsie hépatique
- D-IRM abdominale
- E-Recherche de BK par tubage gastrique

Cas Clinique 12 :

Une fille de 5 ans a consulté les urgences pour douleur aigue du pli de l'aîne et impotence fonctionnelle totale du membre inférieur gauche sans notion de traumatisme récent.

L'interrogatoire a montré la notion d'angine traitée il y a cinq jours avec absence de traumatisme récent. L'examen physique a révélé une température à 38°C, un bon état général, une marche impossible et une mobilité de la hanche gauche limitée et douloureuse.

110. Quel sont les diagnostics à évoquer chez cette enfant c le plus probable

- A- arthrite aigue infectieuse de la hanche gauche
- B- ostéomyélite du col fémoral gauche
- C- rhume de la hanche gauche
- D- une luxation congénitale de la hanche gauche
- E- un fracture du col du fémur gauche

111. Quels sont les deux examens d'imagerie à pratiquer de première intention pour aider au diagnostic

- A- Un scanner du bassin
- B- Une IRM du bassin
- C- Une radiographie du bassin
- D- Une échographie de la hanche gauche
- E- Une scintigraphie osseuse

L'enfant a été hospitalisée pour suspicion d'infection ostéo-articulaire de la hanche gauche. Le bilan inflammatoire a montré : une CRP à 7 mg/ml, une VS à 5/10, des GB à 7000 élt/mm³. La radiographie du bassin était sans anomalies. L'échographie de la hanche gauche a mis en évidence un épanchement anéchogène de faible abondance.

L'évolution était favorable après 48 h de repos et de traitement antalgique et anti-inflammatoire.

112. Quel est le diagnostic le plus probable

- A- Arthrite aigue infectieuse de la hanche gauche
- B- Ostéomyélite du col fémoral gauche
- C- Rhume de la hanche gauche
- D- Une luxation congénitale de la hanche gauche
- E- Une fracture du col du fémur gauche

Cas clinique 13 :

Le nourrisson, âgé de 4 mois, sans antécédents pathologiques notables, consulte pour dyspnée expiratoire débuté la veille. A l'arrivée : T° = 37,8 °C ; FR = 38/min ; saturation = 98 % ; FC = 135/min ; TA = 85/56 mm Hg. Elle est en bon état général. Elle a un tirage intercostal et sus-claviculaire. Elle conserve une excellente perfusion périphérique avec absence d'hépatomégalie. L'auscultation retrouve des sibilants et des crépitants.

113. Quel(s) est (sont) le(s) diagnostic(s) compatible(s) ?

- A. Bronchiolite
- B. Asthme du nourrisson
- C. Myocardite
- D. Pneumonie
- E. Trachéite

114. Quelle est votre prise en charge aux urgences ?

- A. Hospitalisation
- B. Corticothérapie orale
- C. Nébulisation d'adrénaline

- D. Kinésithérapie respiratoire
- E. Désobstructions rhinopharyngées

115. Quelle(s) mesure(s) est (sont) à proposer en prévention des récides ?

- A. Arrêt du tabagisme maternel
- B. Traitement par inhibiteur de la pompe à protons
- C. Sérothérapie anti-VRS par palivizumab
- D. Lavage des mains en période épidémique
- E. Antibiothérapie alternée

Cas clinique 14 :

Un patient âgé de 22 ans présente le profil métabolique suivant: cholestérol total: 1,8 g/l; triglycérides: 15 g/l; HDL-cholestérol: 0,6 g/l; glycémie: 4,8 mmol/l. Son sérum à jeun est lactescent. À l'épreuve de décantation, on trouve un collet avec un surnageant crémeux. Sur le plan clinique: IMC: 23; TA: 120/88 mm Hg; absence de xanthome; foie et rate normaux. Pas de médicament ni de prise d'alcool.

116. Quelle lipoprotéine présente ce patient en excès?

- A- LDL
- B- VLDL
- C- chylomicrons
- D- HDL
- E- IDL

117. Ce patient risque:

- A- un diabète de type 1
- B- un diabète de type 2
- C- une pancréatite aiguë
- D- un IDM
- E- un AVC

118. Ce patient peut être traité par:

- A- régime pauvre en graisses
- B- régime pauvre en glucides
- C- biguanides
- D- fibrates
- E- statines

Cas clinique 15 :

Mr A L., présente des brûlures circonscrites du troisième degré intéressant la poitrine, l'abdomen et le dos.

À H 6 d'hospitalisation et lors d'une intubation oro-trachéale pour détresse respiratoire, le malade présente une inhalation du contenu gastrique pour laquelle il a été mis sous amoxicilline-acide clavulanique et gentamycine.

La prise en charge ultérieure a été essentiellement médicale avec des changements des pansements au bloc opératoire.

119. Quel geste aurait dû être réalisé en priorité ?

- A-sulfadiazine d'argent
- B-débridement de la plaie
- C-escarrotomies

D-analgésie topique
E-pansement stérile.

A J3 d'hospitalisation, le malade présente une oligoanurie de 24 heures avec ascension des chiffres de la créatinine.

120. Quelles sont les principales causes de cette aggravation rénale ?

A-hypovolémie
B-néphrotoxicité
C-rhabdomyolyse
D-syndrome compartimental abdominal
E-lithiase rénale

121. Quelle serait votre prise en charge ?

A-furosémide
B-dopamine
C-hémodialyse
D-hémodiafiltration
E-remplissage vasculaire

Cas clinique 16 :

Un homme âgé de 45 ans, sans antécédents pathologiques notables, était hospitalisé pour fièvre non chiffrée évoluant depuis 1 mois associé à un amaigrissement de 810 kg et une asthénie.

L'examen physique trouvait : une température à 39°C, le poids à 56 kg, une pâleur conjonctivale, des multiples adénopathies inguinales et axillaires, bilatérales, symétriques, fermes, indolores et mobiles de 2 cm de diamètre associées à une splénomégalie.

122- Quel(s) est (sont) le (s) diagnostic(s) à évoquer?

A- Brucellose
B- Lymphome non Hodgkinien
C- Leucémie lymphoïde chronique
D-Tuberculose hématopoïétique
E- Leishmaniose viscérale

Les examens paracliniques de première intention montrent:

-VS: 105 mm à la 1ère heure, CRP à 80 mg/l

-NFS ; GR : 2 900 000/mm³, Hb : 8,2 g/l ; VGM : 94 fl; CCMH à 34 pg; -GB : 7200 éléments/mm³ (PNN à 75%), plaquettes : 120 000/mm³.

-Radiographie thoracique: normale

123- Les diagnostics à évoquer sont

A- Brucellose
B- Lymphome non Hodgkinien
C- Leucémie lymphoïde chronique
D-Tuberculose hématopoïétique
E- Leishmaniose viscérale

L'échographie abdominale a objectivé des coulés ganglionnaires coelio-mésentérique, péri-aortico-cave et iliaques droite d'allure compressive, une hépatomégalie et une splénomégalie.

124- Le diagnostic à évoquer est

- A- Brucellose
- B- Lymphome non Hodgkinien
- C- Leucémie lymphoïde chronique
- D-Tuberculose hématopoïétique
- E-Leishmaniose viscérale

125- Comment confirmer ce diagnostic ?

- A- Sérologie Wright
- B- Myélogramme
- C- Sérologie leishmaniose
- D- Biopsie ganglionnaire
- E- Recherche de BK par tubage gastrique

Fin de l'épreuve